

כאבים בחזה

כאבים בחזה הם תלונה נפוצה שמופיעה לעיתים קרובות עם אירועים מסכני חיים (כגון MI או דיסקציה של האאורטה). עם זאת, יש גורמים רבים נוספים שיכולים לגרום לכאבים בחזה.

אטיולוגיה

מבחינת אטיולוגיות, כאבים בחזה יכולים לנבוע מחמש מערכות מרכזיות:

- המערכת הקרדיווסקולרית
- מערכת הנשימה
- המערכת המוסקולוסקלטלית (גורמים הקשורים למערכות השרירים והשלד)
- המערכת הגסטרואינטסטינלית (גורמים הקשורים למערכת העיכול)
- גורמים פסיכיאטריים

בטבלה 19.1 יש פירוט של פתולוגיות נפוצות לפי אטיולוגיה. זהו פירוט של כלל האבחנות המבדלות הנפוצות במטופלים עם כאבים בחזה

טבלה 19.1 אבחנה מבדלת לכאבים בחזה

קרדיווסקולרי	נשימתי	גסטרואינטסטינלי	מוסקולוסקלטלי	פסיכיאטרי
ACS	PE	כיב פפטי (אולקוס)	שריר תפוס	התקף חרדה
דיסקציה של האאורטה	פנאומוניה וברונכיוליטיס	ריפלוקס (GERD)	קוסטוכונדריטיס (דלקת בסחוסי הצלעות)	דיכאון
אנדוקרדיטיס	ברונכוספאזם חריף בחולי COPD או אסתמה	כוליציסטיטיס	טראומה לבית החזה (שברים בצלעות ופגיעה ברקמה רכה)	
פרימיוקרדיטיס	תפליט פלאורלי	קרע ושטי	פיברומיאלגיה	
מחלות מסתמיות חריפות (אקוטיות)	יתר לחץ דם ריאתי			
תפליט פריקרדיאלי	פנאומוטורקס			

התמונה הקלינית (הקליניקה)

מרבית ההפרעות ממקור קרדיווסקולרי, ובייחוד **הפרעות איסכמיות**, מתבטאות בכאבים **אנגיוטיים**: כאבים לוחצים, דיפוזיים, לא משתנים במגע ובנשימה, מתגברים במאמץ, לעיתים מקרינים ללסת או לידיים, לעיתים מלווים בבחילות והקאות. הפרעות ממקור זה גם נוטות להוביל **לחיוורון**, **הזעה וחולשה ניכרת**. לעיתים קרובות מאוד כאבים אנגיוטיים מגיבים למתן ניטריטים, אך היעדר תגובה אינו שולל מקור איסכמי.

אנדוקרדיטיס בקטריאלי מלווה בדרך כלל בסימני מחלת חום, הפרעות נוירולוגיות ו**כאבים פלאוריטיים**: כאבים דוקרים המתגברים בנשימה עמוקה, אך לא מושפעים ממגע או משינוי תנוחה.

פריקרדיטיס ומיוקרדיטיס יכולים להתבטא הן בכאבים **אנגיוטיים** והן בכאבים **פלאוריטיים**, ולעיתים הם **מוקלים ברכינה קדימה**.

הפרעות נשימתיות - מתבטאות במיוחד **בכאבים פלאוריטיים**. כמו כן אפשר למצוא שיעול ועיטוש, סימנים למצוקה נשימתית, ממצאים בהאזנה לריאות ועוד.

כאבים ממקור מוסקולוסקלטלי - נוטים להיות **נקודתיים, דוקרים ורגישים לתנועה**. כאבים אלו מוחמרים מאוד במגע, בנשימה ובשינוי תנוחה. יש לשים לב שגם דיסקציה של אאורטה עשויה להתבטא כך. בשברים בצלעות אפשר יהיה למצוא המטומה, ובעת מישוש הצלע הדיסטלית לפגיעה יופיעו כאבים חזקים. מקרה חריג של שברים בצלעות הוא חזה צנוח, מרפרף (flail chest), וסימן ההיכר של הפרעה זו הוא נשימה פרדוקסלית.

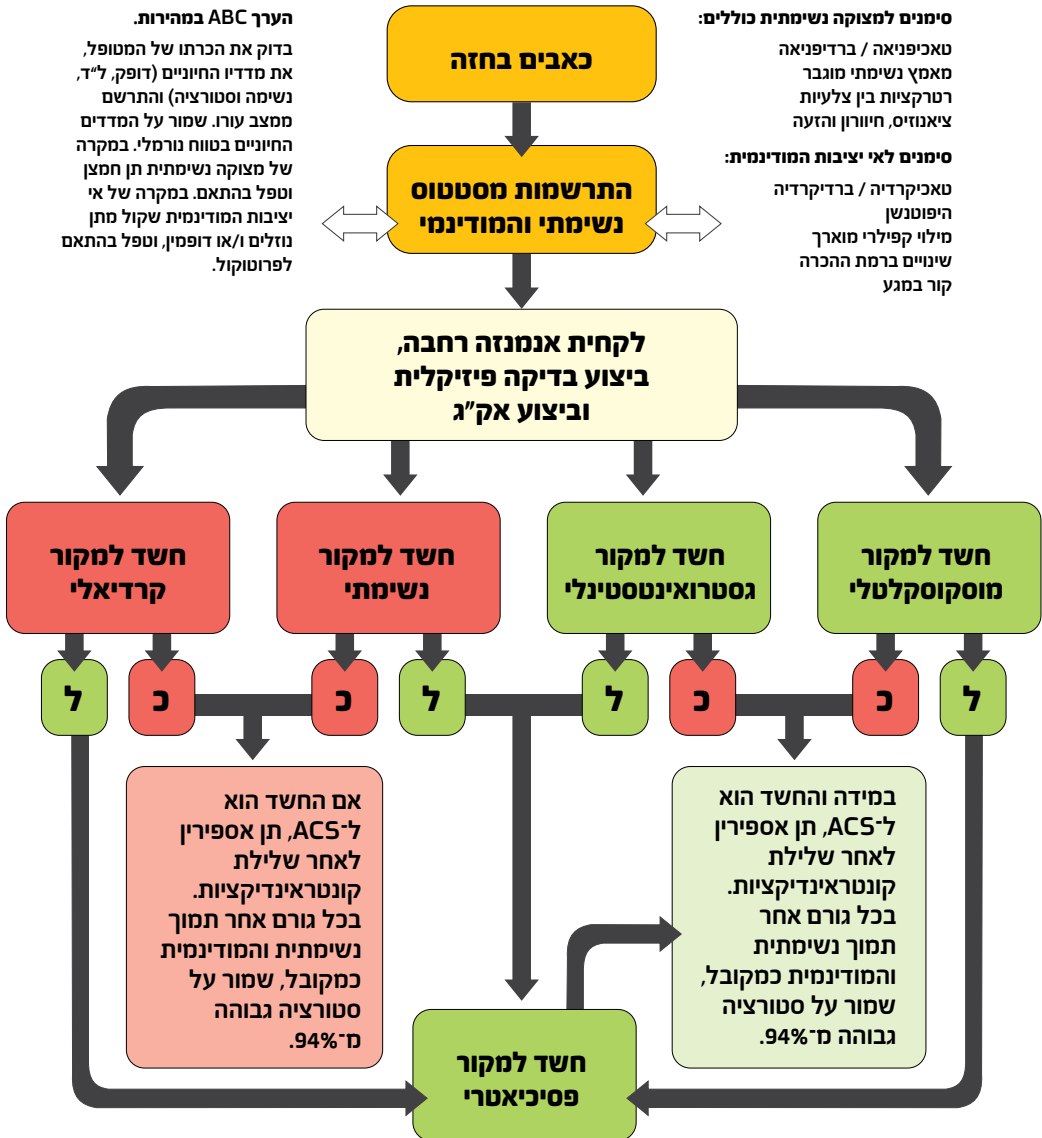
כאבים ממקור גסטרואינטסטינלי - בדרך כלל מתוארים **כשורפים או צורבים**, והם יכולים להיות קשורים לאכילה (לעיתים מוקלים לאחר אכילה ולעיתים מוחמרים). לעיתים קרובות הפרעות אלו מופיעות עם בחילות והקאות. יש לשים לב במיוחד להקאות דמיות. כאבים אלו בדרך כלל מוקלים במתן תרופות נוגדות צרבת.

כאבים ממקור פסיכיאטרי - יכולים להתבטא בתצורות רבות, ולכן אבחנות אלו נעשות על דרך השלילה. בדרך כלל מדובר במטופלים ללא גורמי סיכון קרדיאליים מרובים ועם היסטוריה פסיכיאטרית.

טיפול וניהול המקרה

בכל מטופל עם כאבים בחזה מחפשים את מקור הכאבים ומטפלים בהתאם. ראשית יש לחשוד בגורם קרדיאלי ובגורם נשימתי. מבררים פרטים על אירועים קודמים, רקע רפואי וגורמי סיכון קרדיאליים. מבצעים תרשים אק"ג בכל מטופל המלין על כאבים בחזה, ובייחוד באלו שרואים אצלם כאב אנגיוטי או חולשה עם חיוורון והזעה.

יש לשים דגש על אנמנזה מדוקדקת ובדיקה פיזיקלית מקיפה. יש לשים לב למצוקה נשימתית, לסימני הלם ולשינויים ברמת ההכרה (תרשים 19.1).



תרשים 19.1 טיפול וניהול מקרה של מטופל עם כאבים בחזה

כאבי בטן (Abdominal Pain)

אין תלונות רבות שהן אתגר קליני כמו כאבי בטן (כאבים אבדומינליים, abdominal pain). האבחנה המבדלת לכאבי בטן היא גדולה מאוד, אולי הרחבה ביותר בעולם הרפואה. יש בבטן מבנים אנטומיים רבים: שרירים, כלי דם גדולים, דרכי עיכול, כבד, לבלב, כליות, דרכי שתן ואיברי מין. כל אחד מהם עלול להיות המקור לכאבי בטן. חשוב לעשות אנמנזה מקיפה לכאבים אלו ולהקפיד על בדיקה פיזיקלית מדוקדקת. מטרת ההערכה היא לזהות **בטן כירורגית (בטן חריפה, בטן אקוטית)**. מרבית כאבי הבטן נובעים ממקור שפיר, אך כ-10% מן המטופלים שנבדקים במלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה, חדר מיון) בשל כאבי בטן סובלים מפתולוגיה מסכנת חיים.

יש הפרעה אידיופתית הנקראת מיגרנה בטנית (eniargim lanimodba) זו תופעה המופיעה לרוב רק בילדים, והיא מתבטאת בהתקפים של כאבי בטן. למטופלים האלה יש כאבי בטן קשים שנמשכים 2-27 שעות, מלווים בבחילות, הקאות, חיוורון והיעדר תיאבון. בין ההתקפים מטופלים אלה אסימפטומטיים לחלוטין, והם אינם סובלים ממחלות אחרות.

דגשים באבחנה

אופי הכאב

כאב ממושט ועמום מעיד על מקור ויסצרלי לכאבים (כלומר מאיברי הבטן עצמם). לעיתים קרובות תחילה יופיעו כאבים עמומים, ועם הזמן הכאבים יתמקמו באזור ספציפי. לדוגמה: אפנדיציטיס (דלקת התוספתן). ככל שהכאב שטחי יותר הוא יהיה חד, נקודתי ודוקר יותר.

הופעת הכאבים

הופעה פתאומית של כאבי בטן חריפים מעידה על קרע באיבר, אירוע וסקולרי או ספאזם של דרכי השתן או דרכי המרה. כאבים המופיעים במהירות מחשידים לסטרנגולציה של המעי (חסימת מעיים) או לפנקריאטיטיס (דלקת הבלב, pancreatitis).

מקום הכאב

מקום הכאב הוא פרט אנמנסטי (אבחנתי) חשוב ביותר. נהוג לחלק את הבטן בשתי תצורות, לרבעים ולריבועים (ראו טבלה 19.2). כאבים אפיגסטריים (בבטן עליונה) מעידים על גורם מן הקיבה או מהתריסריון. גורמים מהבלב מתייצגים באזור הבטן העליונה. כאבים מן המעי הדק הם בדרך כלל דיפוזיים וקשה למקמם, אך בדרך כלל הם יהיו פריאומביליקליים (סביב הטבור). כאבים שנובעים מהתוספתן נוטים להתחיל ככאבים ויסצראליים עמומים באזור פריאומביליקלי, ובהמשך לנוע לכיוון הבטן הימנית התחתונה. כאב המקרין לכתף נובע מגירוי דלקתי שבו מעורבת הסרעפת. כאבים ביליאריים (שמקורם מדרכי המרה) מקרינים לסקפולה הימנית ולאפיגסטריים השמאלי. כאבים ביליאריים יכולים לעיתים להתייצג ככאבים אנגינטיים.

מין וגיל

בנשים בגיל פוריות יש לתשאל בנוגע למחזור הווסת ולפעילות המינית. כמו כן יש לתשאל על הפרשות מסריחות מן הנרתיק (מעיד על PID). כל כאב חריג בנשים בגיל פוריות מחשיד בראש ובראשונה להיריון אקטופי.

רמזים לבטן חריפה

חום, הקאות (בייחוד הקאות דמיות), סינקופה, שלשולים דמיים, בטן קשה, סימני גירוי צפקי (פריטוניאלי).